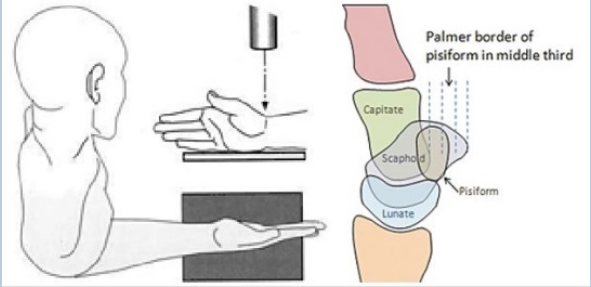
RG Håndledd barn

Endring siden forrige versjon
Forlenget gyldighet til 10.12.2027 uten endringer i dokumentet.

Sammenligningsbilde
Kontralateral side kun på forespørsel fra henviser etter konferering med radiolog, eller på forespørsel fra radiolog.

Indikasjon	Smerteutredning, skade, kontroll	*Front PA, Side, Side med skråpute*

FRONT PA		
INFORMASJON		
POSISJONERING	Armen i PA på detektor. Armen løftet med 90° i skulderledd og 90° i albue.	
SENTRERING	I håndleddets midtlinje, midt på håndrøttene, omtrent 1cm distalt for processus styloideus ulna	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Radius og ulna fremstilles uten rotasjon, samt uten overprojisering av hverandre. Hånden uten deviasjon. Inkluder 1/3 av underarm, nesten hele metacarpene og tommelens grunnledd.	
KOMMENTAR	Ved 90° i skulder og albue unngår man rotasjon av radius og ulna, og de visualisering i sann lengde, og man unngår skråstilling av håndleddet.	
SIDE		
INFORMASJON		
POSISJONERING	Bord/arm senkes ned med armen inntil kroppen. Håndleddets ulnarside skal ligge mot detektor.	
SENTRERING	I radius' midtlinje, midt på håndrøttene, omtrent 1cm distalt for processus styloideus radii.	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Radius og ulna overprojiseres, med 2. til 5 metacarp på linje og overprojisert av hverandre. Hånden uten ventral eller dorsal fleksjon. Det skal være en rett linje gjennom radius, lunatum, capitatum og 3.metacarp. Helt distalt skal radius visualiseres uten å overprojisere ulna dorsalt. Inkluder 1/3 av underarm og nesten hele metacarpene.	
KOMMENTAR		

SIDE MED SKRÅPUTE		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Skal ikke tas på kontroll av skade på barn under 10 år	
POSISJONERING	Med ulnarsiden vendt mot detektor og albuen på underlaget, heves distale underarm opp fra detektor med en skråpute, nært opptil 23˚, med omtrent 90˚ i albuen. Antall grader kan variere fra person til person.	
SENTRERING	I radius' midtlinje, midt på håndrøttene, omtrent 1cm distalt for processus styloideus radii.	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Radius og ulna overprojiseres, med 2. til 5 metacarp på linje og overprojisert av hverandre. Hånden uten ventral eller dorsal fleksjon. Helt distal skal radius visualiseres uten å overprojisere ulna dorsalt. Den radiale leddflaten fremstilles åpen. Inkluder 1/3 av underarm og nesten hele metacarpene.	
KOMMENTAR		

Referanser

Vedlegg

Slutt på Sjekkliste